ONEMA-POP-017 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

1

ONEMA-POP-017 — Avaliação e Classificação de Lesão por Pressão

1. Identificação institucional, código, título, versão e RT

ONEMA SAÚDE | ONEMA-POP-017 | Avaliação e Classificação de Lesão por Pressão | Versão proposta 2.0 | RT: Enf.

2. Objetivo e abrangência

Avaliar, classificar e documentar lesões por pressão, distinguindo-as de outras etiologias.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, com treinamento e atuação dentro das competências profissionais. Lesões associadas a pressão/cisalhamento; não classificar lesões por umidade, vasculares ou traumáticas como lesões por pressão.

4. Materiais, equipamentos e responsável pelo fornecimento

Paciente: acesso à região, materiais de proteção pactuados; enfermeiro: EPI, régua descartável, iluminação, instrumentos de avaliação, câmera autorizada. Fornecimento pactuado no pedido e confirmado antes da visita.

5. Avaliação clínica e preparação

Avaliar mobilidade, perfusão, sensibilidade, nutrição, umidade, dispositivos, local anatômico, dor, histórico, duração da lesão e pele adjacente.

6. Execução técnica numerada e verificável

1. Confirmar identidade, consentimento, privacidade e higienizar mãos.

2. Identificar localização e mecanismo provável de pressão/cisalhamento; avaliar diferenciais (dermatite, lesão vascular, fricção).

3. Inspecionar pele íntegra quanto a eritema não branqueável e alterações de temperatura/consistência, inclusive em pele escura.

4. Se aberta, limpar conforme protocolo e medir comprimento, largura, profundidade quando apropriado, tecido, exsudato e bordas.

5. Classificar conforme NPIAP: estágio 1 (pele íntegra com eritema não branqueável), 2 (perda parcial), 3 (perda total com gordura visível), 4 (estruturas profundas expostas/palpáveis).

6. Se base oculta por esfacelo/escara, registrar não classificável; se descoloração profunda persistente, considerar lesão tissular profunda.

7. Não atribuir estágio a lesão de mucosa por dispositivo; registrar etiologia específica.

8. Iniciar plano de alívio de pressão, redistribuição de carga e proteção; encaminhar lesões profundas/complexas

conforme gravidade.

9. Fotografar apenas com consentimento e registrar classificação e incertezas, sem “regredir” estágio durante

cicatrização.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Infecção sistêmica, necrose extensa, isquemia, dor desproporcional ou exposição óssea com suspeita de infecção:

avaliação urgente.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar reposicionamento individualizado, inspeção diária, superfícies de suporte e manejo de umidade.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação e consentimento; avaliação inicial e sinais vitais quando indicados; descrição objetiva, classificação/medidas,

intervenção, insumos, resposta, intercorrências, orientações, comunicação e plano de seguimento; assinatura profissional

e trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

2

NPIAP — Pressure Injury Stages — https://npiap.com/resource/resmgr/online_store/npiap_pressure_injury_stages.pdf

NICE — Pressure ulcers: prevention and management CG179 — https://www.nice.org.uk/guidance/cg179